PORADNIK PRAWNO-PRAKTYCZNY: BŁĄD DIAGNOSTYCZNY DENTYSTY (ZANIECHANIE NA TOMOGRAFII CBCT) — OC, PROCEDURA, DOKUMENTY

STAN PRAWNY: 2026 R. NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER INFORMACYJNY I EDUKACYJNY, NIE STANOWI INDYWIDUALNEJ PORADY PRAWNEJ.

---

1. Wstęp i typowy schemat sprawy

- **Wariant A (pierwotne przeoczenie):** Wykonanie tomografii stożkowej CBCT *(Cone Beam Computed Tomography — trójwymiarowe badanie obrazowe 3D, stosowane m.in. w stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji i implantologii)* u pierwszego dentysty — lekarz stwierdza brak zmian chorobowych i brak konieczności leczenia.
- **Wariant B (nawrót po leczeniu / sporna kontrola — np. torbiel 11/12 po resekcji z 2021 r.):** Wcześniejsze skuteczne leczenie (resekcja + wyłuszczenie) i prawidłowe kontrole (np. CBCT z 2023 r.). Sporna kontrola CBCT (np. 04.08.2026) z ustnym „wszystko dobrze, kontrola za rok", bez wdrożenia leczenia. Krótko potem (np. 25.09.2026, ok. 7 tygodni) drugi lekarz stwierdza ropień i nawrót na własnym CBCT. Osią roszczenia jest sporna kontrola, nie leczenie pierwotne.
- **Wizyta weryfikacyjna / kontrolna:** Kolejny lekarz dentysta najpierw wykonuje badanie fizykalne, a następnie własną tomografię CBCT; po wnikliwej analizie wcześniejszego (spornego) badania CBCT stwierdza, że zmiana chorobowa (np. zapalenie okołowierzchołkowe, głęboka próchnica, resorpcja, nawrót torbieli) była widoczna już w spornym badaniu CBCT i powinna być leczona od razu. Dowód kluczowy: pisemne porównanie DICOM obu badań CBCT.
- **Skutek zaniechania:** Rozwój stanu zapalnego, obrzęk twarzy, silne dolegliwości bólowe, konieczność inwazyjnego leczenia (endodoncja mikroskopowa, zabieg chirurgiczny, powikłania) i wysokie koszty leczenia naprawczego.
- **Zasada odpowiedzialności:** Prawidłowe odczytanie CBCT i wdrożenie leczenia w terminie pierwotnym zapobiegłoby rozwojowi powikłań, bólowi i znacząco obniżyłoby koszty. Zaniechanie diagnostyczno-terapeutyczne stanowi błąd w sztuce medycznej.

---

2. Jak działa obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza i podmiotu leczniczego

- **Podstawa prawna:** Art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. 2025 poz. 272). Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz lekarz z indywidualną praktyką musi posiadać ważną polisę OC.

- **Zakres ochrony:** Szkody na osobie wyrządzone działaniem **lub bezprawnym zaniechaniem** ubezpieczonego w okresie trwania ochrony. Obejmuje błędy diagnostyczne (nieprawidłowy odczyt CBCT), błędy terapeutyczne i opóźnienie leczenia. Ubezpieczyciel nie może umownie wyłączyć ustawowego zakresu ochrony.
- **Minimalne sumy gwarancyjne (2026 r.):** Zgodnie z § 3 rozporządzenia MF z 29.04.2019 r. wynoszą one, w okresie ubezpieczenia do 12 miesięcy: **100 000 EUR na jedno zdarzenie / 500 000 EUR na wszystkie zdarzenia** — podmioty udzielające szpitalnych świadczeń zdrowotnych (art. 8 pkt 1 lit. a u.d.l.) oraz **75 000 EUR na jedno zdarzenie / 350 000 EUR na wszystkie zdarzenia** — pozostałe podmioty, w tym gabinety ambulatoryjne i indywidualne / indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i dentystyczne (art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 u.d.l.), tj. ok. 320 000 zł na pojedynczą szkodę. Zdecydowana większość roszczeń stomatologicznych mieści się w tej kwocie.
- **Bezpośrednie roszczenie do ubezpieczyciela (*actio directa*):** Zgodnie z art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego (KC) poszkodowany może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca jest ubezpieczony. Nie ma konieczności wcześniejszego pozywania lekarza ani uzyskiwania wyroku sądowego.
- **Obowiązek wskazania ubezpieczyciela:** Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej pacjent ma prawo do informacji o danych ubezpieczyciela OC i numerze polisy podmiotu leczniczego. *Uwaga: przepis nie wyznacza terminu ustawowego na udzielenie tej informacji (termin 14-dniowy z art. 14 ust. 4 dotyczy wyłącznie danych transgranicznych z ust. 3) — we wzorze pisma wyznaczono rozsądny termin 7 dni.*
- **Termin likwidacji szkody:** Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz art. 817 KC, zakład ubezpieczeń ma **30 dni** na wypłatę odszkodowania od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie (w sprawach skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu, lecz bezsporna część musi zostać wypłacona w terminie 30 dni).
- **Czego można żądać:**
- **Odszkodowanie (art. 444 § 1 KC):** Pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (leczenie naprawcze, zabiegi, leki, dojazdy, badania diagnostyczne, konsultacje). Jeżeli leczenie jest planowane, pacjent ma prawo żądać **wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia** (art. 444 § 1 zd. 2 KC) na podstawie kosztorysu/planu leczenia.
- **Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 w zw. z art. 444 KC):** Jednorazowa rekompensata za cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, obrzęk i zniekształcenie twarzy, stres, nieprzespane noce, lęk przed zabiegami, absencja w pracy).
- **Przedawnienie:** Roszczenia o naprawienie szkody na osobie wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniają się z upływem **3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do**

jej naprawienia (art. 442^1 § 1 i § 3 KC). Momentem powzięcia wiedzy jest zazwyczaj data konsultacji weryfikacyjnej, a nie pierwotne błędne badanie — w wariancie nawrotu liczy się data weryfikacji (np. 25.09.2026), nie data pierwotnego zabiegu (np. 2021). Zgodnie z art. 819 § 4 KC zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczenia (lub zdarzenia) przerywa bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela, a bieg rozpoczyna się na nowo od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

- **Kto odpowiada (art. 430 KC):** Jeżeli lekarz na spornej kontroli (np. dr na kontroli 04.08.2026) działał jako personel placówki, odpowiada podmiot leczniczy jako zwierzchnik za winę personelu. Ustal to z karty wizyty / pieczątki.
- **Przyczynienie (art. 362 KC):** Jeżeli między objawami a sporną kontrolą była przerwa w zgłaszaniu się (np. objaw w kwietniu, wizyta dopiero w sierpniu), ubezpieczyciel może powołać się na przyczynienie i żądać miarkowania. Nie pomijaj tego faktu w chronologii — opisz jednym zdaniem zgodnie z prawdą; osią roszczenia pozostaje sporna kontrola.

---

3. Dostęp do dokumentacji medycznej

- **Podstawa prawna:** Art. 26–28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- **Zasada:** Podmiot leczniczy ma prawny obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi **bez zbędnej zwłoki**.
- **Forma:** Kopia, odpis, wyciąg, wydruk, a w przypadku badań obrazowych — zapis na informatycznym nośniku danych (płyta CD/DVD/pendrive) lub udostępnienie w systemie teleinformatycznym.
- **Koszty:** Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy o prawach pacjenta, **pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie jest bezpłatne** dla pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

---

4. Procedura działania krok po kroku

Krok 1: Zabezpieczenie dowodów (natychmiast)

1. **Wniosek o dokumentację medyczną:** Złożyć niezwłocznie wniosek o wydanie pełnej dokumentacji papierowej oraz cyfrowych plików CBCT (format DICOM/oryginalny) do placówki, która wykonywała sporne badanie — a w wariancie nawrotu: pełna historia (zabieg + kontrole) + sporne CBCT + wpis z dnia spornej kontroli. Osobny wniosek do gabinetu weryfikującego o jego dokumentację.
2. **Dokumentacja fotograficzna:** Codzienne zdjęcia obrzęku twarzy, z widoczną datą, pod stałym kątem (przód i profil).
3. **Dziennik bólu i objawów:** Notowanie dat, nasilenia bólu (skala 0–10), przyjmowanych leków

przeciwbólowych/antybiotyków, objawów towarzyszących (gorączka, bezsenność, trudności w żuciu/mowie).

4. **Zbieranie rachunków i faktur:** Zachowywanie faktur imiennych za każdą wizytę, leki, badania, dojazdy.

Krok 2: Ustalenie ubezpieczyciela OC i numeru polisy

- Skierowanie pisma do podmiotu leczniczego o podanie nazwy ubezpieczyciela i numeru polisy OC na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (można połączyć z wnioskiem o dokumentację).

Krok 3: Uzyskanie opinii i kosztorysu od lekarza weryfikującego

- Kluczowym dowodem jest pisemne zaświadczenie/wpis w dokumentacji od drugiego lekarza weryfikującego, zawierające:
- datę badania (fizykalnego i własnej tomografii CBCT),
- porównanie aktualnego stanu klinicznego ze spornym badaniem CBCT (w wariancie nawrotu: DICOM sporny vs DICOM własny, z datami obu badań),
- jednoznaczne stwierdzenie, że zmiana była widoczna w spornym badaniu CBCT i wymagała wdrożenia leczenia,
- plan leczenia naprawczego wraz z kosztorysem.

Krok 4: Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela OC (lub wezwanie gabinetu)

- Złożenie formalnego zgłoszenia szkody wraz z roszczeniem o odszkodowanie (wyłożenie kosztów leczenia) oraz zadośćuczynienie.
- Dołączenie kompletu dowodów: chronologia, dokumentacja medyczna, nośnik z zapisem CBCT (DICOM), opinia weryfikująca, kosztorys, faktury, zdjęcia obrzęku.

Krok 5: Postępowanie likwidacyjne i ewentualne odwołanie

- Ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji.
- W przypadku odmowy lub rażącego zaniżenia sumy zadośćuczynienia przysługuje: 1. Reklamacja / odwołanie do zakładu ubezpieczeń. 2. Wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego. 3. Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta (jeżeli naruszono prawa pacjenta do dokumentacji lub świadczeń zgodnych z wiedzą medyczną). 4. Droga sądowa (pozew o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądem powszechnym).